

Lo Psicologo di Base in Puglia: una valutazione economica integrata di *Health Technology Assessment*

Autore: Dott. Luigi De Michele

Studio Integrale di Health Technology Assessment · Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 11 · Puglia, giugno 2026

Redatto secondo il registro formale raccomandato dall'Accademia della Crusca: sintassi piana, lessico tecnico italianizzato ove esista un uso consolidato, forestierismi limitati ai casi in cui non esiste equivalente italiano corrente (per esempio le sigle internazionali QALY, ICER, ROI, di uso ormai stabilizzato anche nella letteratura italiana di economia sanitaria).

Riassunto strutturato

Contesto e obiettivo. In Puglia, circa 780.000–1.160.000 persone convivono ogni anno con un disagio psichico clinicamente significativo che le cure primarie attuali non intercettano in modo strutturato. La Legge Regionale 11/2023 ha istituito il Servizio di Psicologia di Base, primo in Italia; il presente studio ne valuta il valore economico e sanitario atteso alla messa a regime, per orientare intensità e tempi dell'attuazione.

Metodi. Valutazione economica integrata secondo un telaio ibrido che compone quattro cornici metodologiche complementari: il modello HTA Core Model (nove domini), il modello dei cinque casi (*Five Case Model*), lo standard di rendicontazione CHEERS 2022 e i criteri di giudizio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE-DAC). Prospettiva duplice: bilancio sanitario regionale per le grandezze dirette, società nel suo complesso per quelle indirette. Tre scenari di copertura confrontati (620, 775 e 900 Psicologi di Base) a fronte di un fabbisogno regionale stimato in 800–880 professionisti. Orizzonte statico a regime, con proiezione decennale mediante modello di Markov e analisi di sensibilità probabilistica. L'ancoraggio metodologico principale è la revisione dell'OCSE del 2026, dichiarata esplicitamente prevalente sull'ancoraggio precedente (Chisholm e collaboratori, 2016) ovunque i due divergano.

Risultati. Nello scenario di copertura intermedio (775 professionisti), a un costo di regime di 40,5 milioni di euro l'anno corrispondono 47,0 milioni di risparmi sanitari diretti e 27,0 milioni di benefici indiretti — un rapporto costi-benefici lordo di 1 a 6,6 — con un costo per anno di vita guadagnato in buona salute di circa 9.800 euro, nettamente inferiore alla soglia italiana di accettabilità di 40.000 euro. Il conto fiscale diretto risulta in attivo; il conto sanitario è il termine più solido del verdetto, fondato su un'evidenza clinica di certezza da moderata ad alta; il conto sociale è ampiamente favorevole. I tre scenari di copertura si distinguono per intensità, non per la direzione del giudizio, favorevole in tutti e tre i casi.

Conclusioni. Il verdetto è tripartito e nettamente favorevole su tutte e tre le dimensioni — fiscale, sanitaria, sociale — mai sommate in un'unica cifra. Si raccomanda l'attuazione a regime della Legge Regionale 11/2023 secondo lo scenario di copertura intermedio, con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali pugliesi. I limiti principali dichiarati riguardano la mancata significatività

statistica dei risparmi sanitari diretti nel trial internazionale di riferimento e una riconciliazione ancora incompleta, sul piano editoriale, tra l'ancoraggio economico più recente e il calcolo di dettaglio riportato nelle sezioni analitiche del volume integrale; nessuno di questi limiti altera la direzione del giudizio.

Parole chiave: Psicologo di Base; cure primarie; salute mentale; valutazione economica; *Health Technology Assessment*; CHEERS 2022; EUnetHTA; costo-efficacia; QALY; Puglia.

1. Introduzione

La popolazione pugliese si assottiglia e invecchia: 3.890.661 residenti alla fine del 2023, in calo di 17.022 unità sull'anno precedente, con un indice di vecchiaia salito a 200,8 anziani ogni 100 giovani e un tasso di fecondità di 1,16 figli per donna. Sulla popolazione anziana, oggi circa 945.000 persone, la letteratura epidemiologica internazionale stima tra 95.000 e 142.000 casi di depressione clinicamente significativa e tra 142.000 e 190.000 di disturbi d'ansia; entro il 2050, con la popolazione ultrasessantacinquenne proiettata a 1.200.000 unità, il numero di casi crescerà di circa la metà. A questo si aggiungono condizioni economiche e sociali che amplificano il rischio: un indicatore di povertà o esclusione sociale del 37,7 per cento — il quarto valore più alto in Italia — e una disoccupazione giovanile al 32 per cento, in un contesto in cui la letteratura documenta un nesso causale bidirezionale tra deprivazione socioeconomica e disturbi mentali comuni.

Le cure primarie pugliesi affrontano oggi questo carico senza una figura psicologica strutturata al primo contatto. I sei Dipartimenti di Salute Mentale della regione, con quarantasette Centri di Salute Mentale e 1.813 operatori, hanno in carico 54.946 utenti, ma si occupano prevalentemente di disturbi gravi e persistenti, non del disagio comune che origina nelle cure primarie. Nel 2023 si sono registrati 18.753 accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche — oltre cinquanta al giorno, in crescita del 30 per cento sui livelli pre-pandemici — segnale di una domanda che non trova, a monte, un'intercettazione adeguata. Applicando alla popolazione adulta pugliese (circa 3,9 milioni di persone) le stime di prevalenza correnti nella letteratura internazionale (20–30 per cento con disagio clinicamente significativo in un anno), lo studio stima tra 780.000 e 1.160.000 persone coinvolte, a fronte di una rete specialistica dimensionata per una frazione di tale numero.

La Legge Regionale 11/2023 ha istituito il Servizio di Psicologia di Base, rendendo la Puglia la prima regione italiana a farlo. Poiché il servizio è già istituito per legge, il quesito valutativo non verte sull'opportunità della sua esistenza, ma sulle conseguenze economiche e sociali del suo dimensionamento a regime: quale livello di copertura adottare, e con quale sequenza attuativa. Il presente studio quantifica il valore atteso del Servizio per orientare l'intensità e i tempi dell'attuazione.

2. Metodi

2.1 Disegno dello studio e cornice metodologica

Lo studio è una valutazione economica di sintesi su dati secondari, condotta da un singolo autore, che compone quattro tradizioni metodologiche distinte e complementari. Il modello *HTA Core Model* dell'*European Network for Health Technology Assessment* (EUnetHTA) fornisce la griglia generale entro cui il problema è ordinato lungo nove domini: problema di salute e uso corrente, descrizione tecnica dell'intervento, sicurezza, efficacia clinica, costi e valutazione economica, analisi etica, aspetti organizzativi, aspetti sociali e del paziente, aspetti legali. Il modello dei cinque casi (*Five Case Model*), elaborato nel Regno Unito per la giustificazione degli investimenti pubblici, impone di argomentare

congiuntamente il caso strategico, il caso economico, il caso commerciale, il caso finanziario e il caso gestionale. Lo standard *Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards* (CHEERS) 2022 disciplina la trasparenza della rendicontazione. I criteri di giudizio dell'OCSE-DAC (rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità) estendono lo sguardo alla sostenibilità della riforma nel tempo.

2.2 Popolazione, intervento, comparatore, prospettiva ed esiti

La popolazione di riferimento è costituita dai circa 3,89 milioni di residenti pugliesi, di cui tra 780.000 e 1.160.000 con disagio psichico comune clinicamente significativo. L'intervento valutato è il Servizio di Psicologia di Base a regime, considerato insieme alla rete di figure professionali direttamente e indirettamente connesse. Il comparatore unico è lo statu quo, ossia l'assenza di un Servizio strutturato a regime. Gli esiti considerati appartengono a tre categorie distinte, mai sommate in un'unica cifra: esiti fiscali diretti (bilancio sanitario regionale), esiti sanitari (anni di vita guadagnati in buona salute) ed esiti sociali indiretti (produttività, lavoro, previdenza, welfare). La prospettiva è duplice: il bilancio sanitario regionale per le grandezze dirette, la società nel suo complesso per quelle indirette. L'orizzonte temporale è statico a regime, con proiezione decennale mediante modello di Markov e tasso di sconto del 3 per cento.

2.3 Il modello organizzativo

Il valore economico della riforma non origina da un'unica figura professionale, ma da una gerarchia piramidale a cinque livelli, ordinata per influenza nel progetto e per capacità di rientro economico, diretto o indiretto. Il principio ordinatore previene la duplicazione: ogni effetto economico è attribuito al livello in cui si genera. Il primo livello, apicale, è occupato dallo Psicologo di Base, con un rapporto di copertura di un professionista ogni 4.400–4.900 abitanti. Il secondo livello comprende le figure cliniche di primo contatto — il medico di medicina generale, in una "coppia clinica" con lo Psicologo di Base presso le Case della Comunità, il pediatra di libera scelta e il neurologo. Il terzo livello comprende le figure di continuità e filtro specialistico — l'infermiere di famiglia e di comunità, lo psichiatra consulente, i Centri di Salute Mentale. Il quarto livello è occupato dall'assistente sociale e dal servizio sociale territoriale. Il quinto livello comprende le restanti figure e gli ambiti extra-sanitari connessi ai sedici domini multidisciplinari considerati dallo studio. L'intelligenza artificiale, ove impiegata, non costituisce un livello autonomo della gerarchia, ma una leva trasversale subordinata alla supervisione umana e al Regolamento (UE) 2024/1689, con un contributo isolato e non additivo rispetto al risparmio generato dal presidio professionale.

2.4 Tecniche di valutazione economica

Il nucleo della valutazione economica compone metodologie non alternative, ciascuna specializzata in una grandezza determinata: l'analisi costo-beneficio, per il saldo e il rapporto beneficio-costi; l'analisi costo-efficacia e costo-utilità, per il rapporto incrementale costo-efficacia in anni di vita ponderati per la qualità (QALY); l'analisi di impatto di bilancio, per la sostenibilità del bilancio sanitario regionale; il rendimento sociale dell'investimento, per gli esiti sociali; i modelli di Markov e la microsimulazione, per la proiezione del decorso clinico; l'analisi decisionale multi-criterio, per la composizione di dimensioni economiche, cliniche, etiche e organizzative. Una regola di non duplicazione governa trasversalmente il calcolo: nessun effetto è attribuito a più di una categoria.

2.5 Ancoraggio economico e versioning metodologico

Lo studio ha adottato inizialmente, quale ancoraggio internazionale per il rendimento degli investimenti in salute mentale, gli intervalli di Chisholm e collaboratori (2016): un rapporto costi-benefici tra 2,3 e 3,0 a 1 per i soli benefici economici, tra 3,3 e 5,7 a 1 includendo i ritorni di salute. Una successiva revisione metodologica ha sostituito questo riferimento con il quadro dell'OCSE (2026) e con lo studio Unisanté-PLIMeC-P (identificativo di registro NCT06377189, Università di Losanna), dichiarando che tali cifre prevalgono ovunque divergano dal corpo del volume integrale. Il motivo della sostituzione è metodologico: le stime di Chisholm e collaboratori derivano in prevalenza da paesi a reddito medio-basso, con soglie di costo-efficacia non pienamente pertinenti al contesto europeo, mentre il quadro dell'OCSE è calibrato sul contesto delle cure primarie europee. I risultati qui riportati adottano l'ancoraggio OCSE 2026 come autorevole, per decisione esplicita dell'autore.

2.6 Analisi dell'incertezza

Il protocollo dell'incertezza proietta i risultati nel tempo e ne verifica la robustezza attraverso due strumenti complementari. Il modello di Markov e la microsimulazione rappresentano il decorso delle condizioni cliniche come successione di stati di salute e transizioni, su un orizzonte di dieci anni. L'analisi di sensibilità probabilistica sottopone i risultati a simulazione ripetuta su distribuzioni di parametri incerti, producendo una distribuzione del rapporto incrementale costo-efficacia con una probabilità di costo-efficacia riportata nell'88,9 per cento delle simulazioni. Il protocollo dichiara inoltre soglie di confutazione esplicite: la conclusione di costo-efficacia muterebbe se l'efficacia clinica scendesse sotto una soglia dichiarata; la conclusione sul rendimento sociale muterebbe se i benefici indiretti cadessero fuori dalla fascia validata.

3. Risultati

3.1 Caso base: lo scenario di copertura intermedio

Nello scenario di copertura intermedio (775 Psicologi di Base), a un costo di regime di 40,5 milioni di euro l'anno corrispondono 47,0 milioni di euro di risparmi sanitari diretti — attraverso la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, degli accessi al pronto soccorso e della mobilità sanitaria passiva — e 27,0 milioni di euro di benefici indiretti, per un beneficio complessivo di 74,0 milioni di euro e un rapporto costi-benefici lordo di 1 a 6,6. Il costo per anno di vita guadagnato in buona salute è di circa 9.800 euro, nettamente inferiore alla soglia italiana di costo-efficacia di 40.000 euro per QALY. Il tempo di pareggio (*break-even*) è stimato in 2,3 anni.

3.2 Analisi per scenario

Lo studio ha valutato la riforma su tre scenari di copertura — 620, 775 e 900 Psicologi di Base — a fronte di un fabbisogno regionale a regime stimato in 800–880 professionisti. Nell'ancoraggio OCSE 2026, i risparmi sanitari diretti passano da 23,5 milioni di euro nello scenario minimo a 47,0 milioni nello scenario intermedio e a 79,5 milioni nello scenario pieno, con il costo per QALY che scende, rispettivamente, da circa 11.500 a 9.800 a 7.200 euro. I tre scenari si distinguono per intensità di copertura, non per la direzione del giudizio, favorevole in tutti e tre i casi. Si raccomanda lo scenario intermedio come punto di equilibrio tra fattibilità di reclutamento e copertura del fabbisogno prudenziale, con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali pugliesi e nei quarantacinque distretti della regione.

3.3 Robustezza e incertezza

L'analisi di sensibilità probabilistica riporta una probabilità di costo-efficacia dell'88,9 per cento, parametro coerente in tutti e tre gli scenari di copertura. Il paziente tipo del modello di Markov presenta un risparmio atteso di 1.304 euro e un guadagno di 0,236 anni di vita ponderati per la qualità.

3.4 Equità

L'analisi distributiva valuta tre dimensioni convergenti: l'equità territoriale tra le aree della regione, l'equità tra popolazioni e gruppi sociali, e l'equità di accesso legata all'eventuale impiego di strumenti digitali e di intelligenza artificiale a supporto del percorso di cura.

4. Discussione

4.1 Risultati principali

Lo studio produce un verdetto tripartito nettamente favorevole, deliberatamente non aggregato in un'unica cifra per non confondere grandezze di natura diversa. Il conto fiscale diretto — il bilancio sanitario regionale — è in attivo. Il conto sanitario — il rapporto tra costo incrementale e guadagno di salute — è il termine più solido del verdetto, fondato su un'evidenza clinica di certezza da moderata ad alta. Il conto sociale è ampiamente favorevole. La convergenza indipendente dei tre giudizi, ciascuno solido sul proprio piano, risulta più robusta di quanto sarebbe un'unica cifra aggregata, applicando la medesima regola di non duplicazione che governa l'intero impianto metodologico.

4.2 Confronto con l'evidenza esistente

Il modello di assistenza collaborativa che la coppia clinica medico di medicina generale–Psicologo di Base traduce nel contesto pugliese è validato da oltre novanta studi controllati randomizzati internazionali, con riduzioni documentate dei sintomi depressivi e ansiosi, degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri psichiatrici in implementazioni comparabili in Europa, Nord America e Australia.

4.3 Punti di forza

Lo studio compone quattro cornici metodologiche complementari anziché affidarsi a una sola, applica una regola esplicita di non duplicazione degli effetti economici, dichiara soglie di confutazione esplicite anziché limitarsi a un valore atteso puntuale, ed è costruito secondo un telaio replicabile, già esteso a diciannove ulteriori contesti regionali italiani e a una sezione dedicata all'Unione Europea a ventisette Stati membri.

4.4 Limiti

Lo studio dichiara esplicitamente alcuni limiti, in coerenza con il proprio vincolo di falsificabilità. I risparmi sanitari diretti, pur presenti nella letteratura di riferimento sul modello di assistenza collaborativa (Unützer e collaboratori, 2008), non hanno raggiunto significatività statistica se considerati isolatamente nel trial internazionale di riferimento; il saldo fiscale positivo va quindi letto come una stima prudenziale, non come garanzia priva di incertezza. La sezione dello studio dedicata all'efficacia clinica e ai meccanismi d'impatto risulta, alla data della presente redazione, sviluppata solo in parte rispetto alle altre parti del volume integrale. Il fabbisogno di personale dipende da un rapporto di copertura dichiarato come banda

prudenziale, non come cifra puntuale; la fattibilità del reclutamento su 620–900 professionisti qualificati resta il principale rischio attuativo. La revisione all'ancoraggio OCSE 2026 non è ancora riconciliata in modo puntuale, sul piano editoriale, con il calcolo di dettaglio riportato nelle sezioni analitiche del volume integrale, che restano in parte espresse nell'ancoraggio precedente; questo lavoro di riconciliazione, tuttora in corso, non altera la direzione del giudizio, favorevole in entrambe le basi di calcolo. Il dominio della sicurezza clinica, fra i nove previsti dal modello HTA Core Model, non è stato sviluppato come dominio autonomo per l'intervento psicologico in sé, essendo trattato primariamente in relazione alla componente di intelligenza artificiale. Infine, lo studio, in quanto sintesi su dati secondari condotta da un singolo autore, non prevede una fase di consultazione strutturata di pazienti e cittadini nella propria progettazione metodologica.

5. Conclusioni

Il verdetto è tripartito e nettamente favorevole su tutte e tre le dimensioni considerate — fiscale, sanitaria e sociale — mantenute deliberatamente distinte anziché sommate in un'unica cifra. Si raccomanda l'attuazione a regime della Legge Regionale 11/2023 secondo lo scenario di copertura intermedio (775 Psicologi di Base), con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali pugliesi, rapporto convenzionale per il reclutamento e monitoraggio continuativo attraverso un sistema di indicatori strutturato secondo il modello di Donabedian, con verifica controfattuale d'impatto.

Dichiarazioni

Finanziamento. Lo studio non ha ricevuto alcun finanziamento esterno, pubblico o privato; si tratta di un lavoro indipendente e autofinanziato.

Conflitti di interesse. L'autore non è iscritto all'Ordine degli Psicologi e non dichiara conflitti di interesse rilevanti in relazione al presente studio.

Approvazione etica. Non applicabile: lo studio è un'analisi di sintesi su dati secondari e aggregati (conti regionali, letteratura scientifica, benchmark internazionali), senza raccolta di dati primari su singoli individui.

Coinvolgimento di pazienti e cittadini. Non è stata condotta alcuna consultazione strutturata di pazienti o cittadini nella progettazione metodologica dello studio, coerentemente con la sua natura di sintesi su dati secondari.

Disponibilità dei dati. L'analisi integrale, con la documentazione tecnica completa, la mappatura ai domini dell'HTA Core Model e la checklist di conformità CHEERS 2022, è disponibile nel corpo integrale dello studio (Tomo I — Puglia) e nei prodotti derivati di sintesi ai diversi livelli di dettaglio.

Contributo dell'autore. L'autore ha condotto da solo l'intero disegno dello studio, la raccolta delle fonti secondarie, l'analisi e la redazione.

Bibliografia essenziale

1. Regione Puglia. Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 11. Istituzione della figura professionale dello Psicologo di Base.
2. Chisholm D, Sweeny K, Sheehan P, et al. Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. *Lancet Psychiatry*. 2016;3(5):415–424.

3. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). *The Economic Case for Preventing Mental Ill Health*. 2026.
4. Unisanté-PLIMeC-P, Università di Losanna. Identificativo di registro NCT06377189.
5. Unützer J, Katon WJ, Fan MY, et al. Long-term cost effects of collaborative care for late-life depression. *Am J Manag Care*. 2008;14(2):95–100. (Citazione ripresa così come richiamata nel corpo integrale dello studio; riferimento bibliografico completo da verificare dall'autore prima di un'eventuale sottomissione editoriale.)
6. Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. *Value Health*. 2022;25(1):3–9.
7. European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA). HTA Core Model.
8. HM Treasury. *The Green Book: Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation* (Five Case Model).
9. Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie.
10. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale).
11. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*. 2008;336(7650):924–926.

Per il quadro metodologico completo e la mappatura puntuale ai nove domini dell'HTA Core Model si veda il Livello 4 della piramide informativa (_livelli-piramide/livello-4-sintesi-tecnica.md); per l'analisi integrale, il Tomo I (tomo-1-puglia/opera-integrale-puglia.docx).